Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Salto do Jacuí

Av. Hermogênio Cursino dos Santos, 400 - Bairro: Menino Deus - CEP: 99440000 - Fone: (55) 302-99977 - Balcão Virtual: (55) 99639 3180 - Email: frsaltojacvjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000043-52.2024.8.21.0161/RS

AUTOR: NERLI PEREIRA DE SOUZA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

NERLI PEREIRA DE SOUZA ajuizou a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL.

Sustentou, em resumo, que no ano de 2013 foi diagnosticada com câncer de mama, sendo que houve evolução da doença, que avançou para a cabeça e os pulmões, em razão do que o médico responsável prescreveu o uso do remédio "Abemaciclibe". Afirmou não possuir condições para custear o tratamento com este fármaco e que o demandado nega o fornecimento sob a justificativa de que não faz parte de sua lista de distribuição. Ao final, postulou pela procedência do pedido para, confirmando a tutela de urgência, fornecer o tratamento necessário. Pugnou pela concessão da Gratuidade da Justiça e juntou documentos.

O benefício da Gratuidade Judiciária e a tutela de urgência foram deferidos (evento 3, DESPADEC1).

O IPERGS foi citado e apresentou contestação (evento 14, CONT1).

Como preliminar, sustentou ser parte ilegítima para figurar no presente feito ao fundamento que sofreu processo de cisão interna, sendo que o marco principal da segregação ocorreu em relação ao IPE-Saúde e IPE-Previdência. Neste ponto, requereu a correção do polo passivo para o fim de constar apenas o IPE-Saúde. Quanto ao mérito, sustentou que o medicamento postulado não consta nos protocolos clínicos que regulamentam os serviços prestados pela autarquia. Acrescentou que por esta razão atua em nome do princípio da legalidade, de modo que não pode promover tratamentos que não estejam previstos em seus regulamentos. Ressaltou não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Argumentou que existem medicamentos alternativos dentro das tabelas do IPE-Saúde. Postulou a improcedência do pedido. Na hipótese de procedência, requereu fosse considerada a co-participação do segurado, fixação de honorários na forma do artigo 85, § 8.º, CPC e isenção do pagamento de custas processuais. Juntou documentos.

Sobreveio réplica (evento 18, RÉPLICA1).

Em decisão saneadora, foi reconhecida a necessidade de retificação do polo passivo. No mesmo ato, as partes foram intimadas à dilação probatória (evento 22, DESPADEC1).

Considerando que as partes não manifestaram interesse pela produção de outras provas, vieram os autos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo, de imediato, ao exame do mérito.

Em relação ao mérito, tem-se que deve ser julgado procedente o pedido formulado pela parte autora, confirmando a tutela de urgência. Senão vejamos.

No caso objeto do presente feito, a autora comprova a condição de segurada do IPE (evento 1, DOC3), sistema de assistência à saúde dos servidores públicos (e seus dependentes) do Estado do Rio Grande do Sul, cabendo a este, portanto, o atendimento da demanda oriunda de seus contribuintes.

O laudo médico que instrui a inicial, firmado pela médica assistente da parte autora (evento 1, LAUDO9), comprova a necessidade do tratamento requerido, diante do risco de óbito decorrente do agravamento do seu quadro de saúde:

Deverá iniciar o mais breve possível o Abemaciclibe, não podendo trocar por similares, sob risco de progressão do tumor e morte caso não venha a realizar o tratamento proposto. Lembrando que esse tratamento está autorizado para esta indicação pela ANVISA.

Deverá realizar tratamento com abemaciclibe 150 mg via oral duas vezes por dia, por período indeterminado (até progressão do tumor ou intolerância ao medicamento.

Edilson Walter
CREMERS 28118

EDILSON WALTER
MEDICINA INTERNA
ONCOLOGIA CLÍNICA
CREMERS 28118 - CPF 760.062.590-91

Ijuí, 08 de janeiro de 2024

A negativa do demandado ao fornecimento do tratamento de que necessita a autora está comprovada nos autos, conforme documento do evento 1, OUT12.

Todavia, tal negativa não se justifica, porquanto, no âmbito das relações que envolvem o IPERGS e o paciente, devem apenas os tratamentos vedados pela autarquia sujeitarem-se às limitações. Nesse sentido, dispõe o art. 2.º da Lei Complementar Estadual n.º 12.134/2004, que integram o plano os atos necessários ao tratamento e prevenção de doenças[1]. Mesmo que este dispositivo possa ser restringido por norma regulamentadora expedida em momento posterior, descabe à autarquia negar procedimentos ou tratamentos não excluídos de suas regulamentações.

Em outras palavras, o atendimento aos segurados deve ser amplo, compreendendo atendimentos médico, hospitalar e os atos necessários à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, não havendo exclusão de qualquer procedimento.

Anote-se que esta posição encontra amplo suporte jurisprudencial[2], que reconhece o dever da autarquia no fornecimento dos medicamentos mesmo que fora de seus protocolos.

Desse modo, conclui-se pela procedência do pedido, com a ressalva atrelada à possibilidade de ser promovido o regime de co-participação, conforme julgado que segue:

> *"RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. SERVIDORA PÚBLICA. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES PREVENTIVOS BRCA1 E BRCA2. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO Nº 21/79 DO IPERGS. REEMBOLSO DEVIDO. CO-PARTICIPAÇÃO. A Lei Complementar nº 12.134/2004 reestruturou o IPERGS, estabelece que o IPE-SAÚDE abrange todos os atendimentos médicos, hospitalares, materiais relacionados e atos necessários ao tratamento, bem como ações de prevenção de doença e de promoção à saúde, sendo que somente a Lei pode reduzir ou excluir sua abrangência, ficando vedada qualquer disposição que reduza ou exclua cobertura por Regulamento. A Resolução nº 21/79 do IPERGS, por sua vez, prevê expressamente a cobertura integral dos procedimentos necessários ao diagnóstico e tratamento visando identificar o diagnóstico e tratar a moléstia. Precedentes. A necessidade de realização do exame restou devidamente justificada pelo profissional de saúde. Conforme idissonante jurisprudência, não cabe ao Plano de Saúde selecionar o tipo de tratamento médico, uma vez estabelecido que a doença terá cobertura, se há previsão contratual de cobertura da patologia. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007058985, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 10-11-2017)"*

Por fim, a parte ré postulou a fixação de honorários advocatícios em patamar módico, fundamentado no fato de que a presente ação possui valor inestimável, de modo que a fixação desta verba com base no valor da causa ensejaria estímulo à judicialização da matéria e maiores prejuízos à autarquia, que deveria submeter-se a pagamentos elevados, culminando em prejuízo ao atendimento de sua demanda.

Verifica-se que a parte ré possui razão neste ponto, tendo em vista que mesmo diante de causa com valor significativo, o bem da vida postulado é de fato inestimável – a própria saúde. Assim, o ônus sucumbencial deve observar os critérios previstos no art. 85, § 8.º do CPC[3].

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por NERLI PEREIRA DE SOUZA em face do IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, para o fim de CONDENAR a parte ré ao fornecimento do tratamento à autora, conforme prescrição médica (evento 1, DOC10), sob pena de bloqueio de valores e, por conseguinte, CONFIRMO a tutela provisória de urgência concedida no evento 3, DESPADEC1.

Sucumbente o réu, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios em prol do procurador da parte autora, que fixo em R$1.500,00, atendendo-se às diretrizes do artigo 85, §8.º do CPC.

Descabida a condenação da Autarquia Estadual ao pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais, em razão da isenção constante no art. 5º, I, da Lei Estadual nº 14.634/2014.

Dispensada a remessa necessária (CPC, art. 496, § 3.º, II).

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DANIEL SUSIN, Juiz de Direito**, em 4/6/2024, às 13:14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10059960745v7** e o código CRC **6efd8196**.

---

1. Art. 2º - Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde.1º - O Plano IPE-SAÚDE será fundamentado nos princípios da co-participação financeira do usuário e da prestação de serviços, esta mediante o credenciamento de profissionais e pessoas jurídicas da área da saúde. (…). ↩
2. Ementa: PLANO DE SAÚDE. IPERGS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA DE FORNECIMENTO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. Comprovada nos autos a adequação e necessidade do tratamento médico prescrito quimioterapia com o fármaco Rádio 233 (Xofigo®) , por se tratar de segurado portador de câncer de próstata, estágio IV, com metástases ósseas, não fosse inexistência de disposição a excluir fornecimento segundo normas

regulamentares do plano de assistência médica, resta desprovida de fundamento a negativa de disponibilização, impondo-se ao instituto assistencial dever obrigacional quanto ao tratamento oncológico pretendido. (Apelação Cível Nº 70077868578, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 20/06/2018)Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. DEVER DE FORNECIMENTO PELO IPÊ-SAÚDE. 1. O IPERGS tem o dever de fornecer o tratamento postulado, não excluído do Plano de Saúde, e devidamente indicado por médico competente ao paciente, vedada expressamente a limitação do critério médico na escolha de tratamento, nos termos do artigo 16 do Código de Ética Médica. 2. A ausência de previsão de medicamento em listas do IPERGS não impede a realização do tratamento necessário à saúde da parte apelada. Inteligência das Leis nº 7.672/82, LC nº 12.134/2004, art. 196 da CF, e 241 da CE. Precedentes jurisprudenciais. 3. Possível o bloqueio de valores em caso de descumprimento da determinação judicial, a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70077443844, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 12/07/2018). ↩

3. (…).A fixação dos honorários advocatícios, com base no §8º do artigo supracitado, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo ser fixada por apreciação equitativa do juiz. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077292811, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/05/2018). ↩